

Bàng quang tăng hoạt (OAB)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Hiểu về tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát

Bàng quang tăng hoạt (OAB) là tình trạng phổ biến và có thể điều trị được, xảy ra khi cơ bàng quang co bóp không đúng lúc. Điều này gây ra **cảm giác tiểu gấp đột ngột và mạnh**, tiểu nhiều lần, thức dậy ban đêm để đi tiểu, và đôi khi rò rỉ nước tiểu trước khi kịp vào nhà vệ sinh. Đây **không** phải là điều bình thường khi lão hóa, và có nhiều cách để cải thiện tình trạng này.

Về tình trạng này

Bình thường, bàng quang tích nước tiểu từ từ và chỉ báo hiệu khi gần đầy. Khi bị OAB, bàng quang gửi tín hiệu “khẩn cấp” quá sớm hoặc quá mạnh. Các triệu chứng chính gồm:

- **Tiểu gấp** — cảm giác cần đi tiểu đột ngột, khó kiểm chế
- **Tiểu nhiều lần** — đi tiểu hơn khoảng 8 lần mỗi ngày
- **Tiểu đêm** — thức dậy ban đêm để đi tiểu
- **Tiểu không kiểm soát do tiểu gấp** — đôi khi rò rỉ nước tiểu trên đường đến nhà vệ sinh

Nguyên nhân

Thường không có nguyên nhân đơn lẻ — đây là vấn đề về tín hiệu giữa bàng quang và não bộ. Các yếu tố có thể khởi phát hoặc làm nặng thêm gồm **caffeine và rượu bia**, táo bón, thừa cân, một số thuốc, và (ở phụ nữ) thời kỳ mãn kinh. Nhiễm trùng đường tiết niệu cũng gây triệu chứng tương tự, vì vậy cần loại trừ trước. Đôi khi có liên quan đến bệnh lý thần kinh.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bàng quang tăng hoạt (OAB)

Tiểu gấp và tiểu nhiều lần do bàng quang co bóp quá sớm.

Tiểu gấp

Cảm giác cần đi tiểu đột ngột, mạnh mẽ và khó nhịn.

Tiểu nhiều lần

Phải đi tiểu nhiều lần trong ngày.

Tiểu đêm

Thức dậy khi ngủ để đi tiểu.

Tiểu không kiểm soát do tiểu gấp

Rò rỉ nước tiểu kèm theo cảm giác tiểu gấp mạnh.

Nhật ký bàng quang

Sổ ghi đơn giản về lượng uống, số lần đi tiểu và các lần rò rỉ.

Sàn chậu

Các cơ có thể tập luyện để giúp kiểm soát bàng quang.

Tập luyện bàng quang

Dần dần kéo dài thời gian giữa các lần đi tiểu để giảm tiểu gấp.

CÓ CẢI THIẾN KHÔNG? Có — hầu hết bệnh nhân đều cải thiện. Điều trị thường bắt đầu bằng thay đổi lối sống và tập luyện bàng quang, chỉ nâng cấp khi cần thiết. Có thể mất vài tuần để nhận thấy sự khác biệt, vì vậy hãy kiên trì với từng bước và phối hợp với nhóm chăm sóc để tìm ra phương pháp phù hợp.

Chẩn đoán như thế nào

- Hỏi về triệu chứng và xem **nhật ký bàng quang**
- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng hoặc máu trong nước tiểu
- Kiểm tra khả năng tổng nước tiểu (siêu âm bàng quang nhanh)
- Đôi khi cần thêm xét nghiệm (niệu động học hoặc nội soi) nếu chưa rõ nguyên nhân hoặc các phương pháp điều trị trước chưa hiệu quả

Điều trị như thế nào (Từng bước)

- 1 Thay đổi lối sống & tập luyện** — giảm caffeine/rượu bia, kiểm soát lượng uống, trị táo bón, giảm cân thừa, và thực hiện **tập luyện bàng quang** cùng **bài tập cơ sàn chậu**.
- 2 Thuốc** — thuốc uống giúp làm dịu cơ bàng quang.
- 3 Các phương pháp nâng cao** — tiêm **Botox** vào bàng quang, hoặc **kích thích thần kinh** (PTNS hoặc điều biến thần kinh cùng). Mỗi phương pháp có tờ thông tin riêng.

Sống chung với tình trạng này

- Ghi **nhật ký bàng quang** vài ngày để nhận ra các yếu tố kích hoạt.
- Uống nước đều đặn; không uống quá ít vì nước tiểu sẽ trở nên đặc.
- Áp dụng **đi tiểu theo giờ** và kỹ thuật “kiềm chế tiểu gấp” (dừng lại, siết cơ sàn chậu, thở đều, rồi mới đi) do nhóm chăm sóc hướng dẫn.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Tiểu ra máu**, hoặc đau hoặc rát khi đi tiểu
- Sốt, hoặc đau lưng/hông (có thể nhiễm trùng)
- Đột nhiên **không thể đi tiểu**

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- 1. OAB** — tiểu gấp, tiểu nhiều lần, thức đêm đi tiểu, và đôi khi rò rỉ — là tình trạng phổ biến và có thể điều trị, không phải do lão hóa.
- 2. Điều trị tăng dần từng bước:** thay đổi lối sống và tập luyện bàng quang trước, rồi đến thuốc, sau đó là Botox hoặc kích thích thần kinh.
- 3. Nhật ký bàng quang** giúp tìm ra yếu tố kích hoạt; hãy dành vài tuần cho mỗi bước. Gọi cho nhóm chăm sóc nếu có máu trong nước tiểu, đau, sốt, hoặc không thể đi tiểu.